

SEMIOLÓGIA DEL APARATO RESPIRATORIO - MOTIVOS DE CONSULTA.

TOS

Sucesión de movimientos espiratorios violentos a glotis entrecerrada que permite la salida al exterior del aire, secreciones y eventualmente otros materiales de las vías aéreas y los pulmones. Es un reflejo cuyo punto de partida son terminaciones nerviosas libres mielinizadas ubicadas en la mucosa respiratoria, pleura, y otros sitios, correspondientes al neumogástrico, trigémino, glosolaríngeo y nervios intercostales. Los estímulos son inflamatorios, químicos, mecánicos. El centro de la tos se ubica en el Bulbo raquídeo y las vías eferentes son los nervios frénicos, laríngeos inferiores etc

Tipos de Tos Según sus características:

Quintosa

Coqueluchoide

Perruna

Bitonal

Según se acompañe o no de secreción se clasifica en Húmeda y Seca.

Si es húmeda y la secreción se elimina al exterior en forma de expectoración se denomina Tos Productiva.

Según su intensidad: Leve o Intensa.

Según su duración en el tiempo: aguda y crónica.

Complicaciones: Emetizante. Sincope tusígeno. Ruptura pulmonar. Fractura Costal.

Semiología de la Tos. En interrogatorio es importante para la orientación diagnóstica: las características de la tos, momento de aparición, síntomas acompañantes y la ingestión de ciertos fármacos.

Principales Causas:

Respiratorias: Rinitis, sinusitis, faringitis

Laringitis, traqueitis y bronquitis.

Bronconeumonías y Neumonías

Bronquiectasia. Absceso de pulmon.

Carcinoma bronquial

Afecciones Pleurales.

Cardiovasculares: Insuficiencia Cardíaca izquierda

Estenosis mitral

Mediastinales: Tumores primitivos y metastásicos

Bocio intratorácico

Otros: Procesos subfrénicos

fármacos

Neurosis.

EXPECTORACION

(2)

Es la eliminación de secreciones, procedente del aparato respiratorio. Normalmente las glándulas mucosas y las células ciliadas del epitelio bronquial producen más o menos 100 ml/día de secreción seromucosa, que son depuradas insensiblemente.

Clasificación, según aspecto macroscópico del esputo (material expectorado)

1. Serosa: es líquida, espumosa, de color blanco-amarillento a veces rosado, cantidad variable y ~~proviene~~ de la trasudación alveolar. Se ve en casos de Edema pulmonar de cualquier etiología y cuando de "tipo clara de huevo" se origina en un carcinoma bronquiolo-alveolar.
2. Mucosa: es incoloro, transparente y su consistencia variable, a veces fluido y otras espesa, viscosa de difícil eliminación. Se la ve en los periodos iniciales de traqueo-bronquitis agudas y en bronquitis crónicas no complicadas.
3. Mucopurulentas y Purulentas: son opacas, de color amarillento o verdoso. Están constituidas por mucus y pus o por secreción purulenta exclusiva. La "expectoración numular" tiene origen en procesos cavitarios de etiología tuberculosa y también en supuraciones pulmonares y en las bronquiectasias. Tumores infectados. Tienen forma circular como monedas o a veces ovaladas suelen aplastarse en el recipiente y separadas de la masa líquida. La cantidad depende del proceso patológico y del período evolutivo. En las Neumonías al inicio es escasa y luego abundante. En las Bronquitis crónicas y en Tuberculosis son generalmente abundantes. Cuando son muy abundantes y tienen horrible olor pensar en Bronquiectasia. Si tienen olor muy fétido, Absceso pulmonar.
4. Sanguinolenta: Se habla de "esputo Hemoptoico" cuando en el material expectorado se reconocen "estrias de sangre" es una forma mínima de Hemoptisis y debe hacer sospechar la existencia de un Carcinoma oculto de pulmón especialmente en fumadores y el "esputo Herrumbroso" que muy característico del período de estado de las Neumonías especialmente por neumococo.
5. Otras características macroscópicas:
 - a. Cóculos Fibrinosos o Moldes bronquiales: masa blanca o amarillenta, de aspecto arborizado que reproducen las ramificaciones bronquiales, longitud variable de mm a cms, constituidos por fibrina, típicos de las Bronquitis agudas.
 - b. Espirales Bronquiales o de Curchmann: son filamentos retorcidos de uno a mas cms de longitud, color amarillo grisáceo, están constituidos por mucus, se la ve en el Asma bronquial.
 - c. Tapones de Dietrich: son masas opacas del tamaño de un grano de trigo o de poroto, color blanco-amarillento, olor fétido. Constituidos por ácidos grasos, células epiteliales y bacterias. Se la ve en casos de Gangrena pulmonares, Bronquitis pútrida y Bronquiectasias.
 - d. Puede observarse también en el esputo: Fragmentos de tejidos, granos de Actinomicetes, restos de Hidátides, Cuerpos extraños y Bronquiolitos.

VOMICA: Cuando la cantidad de esputo o material expectorado supera los 300 ml se habla de Vómica. Es habitualmente coincidente con accesos de tos y sofocación. Se produce cuando una colectión purulenta se abre en un bronquio. -

op) esputo Pearlado = Asma bronquial, al final de la crisis, contiene los Cristales de Leiden

HEMOPTISIS

(3)

Es la eliminación por la boca de sangre procedente de las vías respiratorias. Lo presentan aproximadamente el 20% de enfermos pulmonares y constituye un síntoma-signo que lleva a la consulta rápidamente.

Generalmente es precedida por un "cosquilleo faringolaríngeo o laringotraqueal" o sensación de burbujeo caliente retroesternal seguido por tos y expulsión de sangre roja rutilante y espumosa (aireada) sin restos alimentarios. Luego en días siguientes hay expectoración hemoptoica oscura, y luego amarillenta por degradación de la hemoglobina.

Las características descritas anteriormente sirve para diferenciar la hemoptisis de la Hematemesis, Epistaxis y Gingivorragias. Además la Hematemesis es precedida de náuseas y vómitos, la sangre es oscura con coágulos y restos de alimentos. Días después hay melena. La epistaxis da sangre roja pero no hay tos y puede reconocerse fácilmente al examen de las fosas nasales. En la gingivorragia se observa la sangre roja que procede de las encías, generalmente edematosas y convulsivas a veces supuradas.

Clasificación de la Hemoptisis según su Volumen:

Mínima o Leve, hasta 250 ml de pérdida.

Moderada: entre 250 a 500 ml.

Grave: entre 500 a 600 ml.

Fulminante: más de 600 ml, produciendo muerte por asfixia o shock.

Etiopatogenia:

Por Hemorragia Bronquial: Carcinoma, Bronquiectasia, Tuberculosis.

Por Hemorragia Alveolar: Hemosiderosis, Granulomatosis de Wegener, vasculitis de Churg-Strauss, Sx. de Goodpasture.

Por Trasudación Alveolar: Insuficiencia cardíaca izquierda.

Por Necrosis: Cavidades o Abscesos.

Frecuentemente en las enfermedades que producen Hemoptisis hay además de lesiones vasculares anastomosis entre circulación pulmonar y sistémica (arterias bronquiales).

X Las Cuatro enfermedades Respiratorias que dan Hemoptisis son: Tuberculosis, Bronquitis Crónica, Cáncer de Pulmón y Bronquiectasias.

Causas Extra pulmonares: Estenosis Mitral, Insuficiencia Cardíaca, Tromboembolismo pulmonar.

→ afección de Rasmussen

DISNEA

Es una sensación molesta, desagradable de dificultad respiratoria, que a veces se acompaña de evidencias objetivas como ser alteraciones de la frecuencia o del ritmo respiratorio.

La sensación de disnea tiene su origen en la estimulación de receptores periféricos y centrales que controlan la actividad de los músculos respiratorios, como la hipoxemia, hipercapnia, el equilibrio ácido-básico y los cambios de la relación presión/volumen del pulmón.

Clasificación:

1) Según criterio Fisiopatológico:

- a- Disnea por Hiperventilación: Ejercicios, Emociones, Altura, Acidosis metabólica, Anemias y Psiconeurosis.
- b- Disnea por Disminución de Capacidad Vital: Enfermedades pulmonares Restrictivas (Atelectasias, Enf. Pulm. Intersticiales) o Enfermedades pulmonares Obstructivas (Asma, Bronquitis crónicas, Enfisema). También comprometen la capacidad vital las Neumonías, Bronconeumonías, Tromboembolismo pulmonar y las Neumoconiosis.

2) Según criterio Etiológico:

- a- Disnea respiratoria por enfermedades que Primariamente afectan al Pulmón, por alteración en la Rigidez pulmonar (Enf. Intersticiales o Intercilio-alveolares). Disminución del calibre bronquial (EPOC) y la Disminución de territorios pulmonares funcionales (Neumonías y atelectasias).
- b- Disnea respiratoria por Enfermedades que Secundariamente comprometen la función pulmonar como ser: patología de la caja torácica (Derrame Pleural, Obesidad, Distensión Abdominal).
- c- Disnea de Causa Cardiovascular: Insuficiencia cardíaca izquierda, la Estenosis Mitral, La pericarditis constrictiva, Derrame pericárdico. Las dos primeras y las cardiopatías congénitas que dan un cortocircuito de izquierda a derecha producen Congestión pulmonar y las Pericardipatías dan Insuficiencia Diastólica.
- d- Otras Causas: Anemia, Hipertiroidismo, Psiconeurosis, Enfermedad neurológica: hemorragia cerebral, meningoencefalitis, Tumores del SNC.

3) Según criterio Clínico: forma de presentación Circunstancias de su aparición:

- a- Disnea de Esfuerzo. Tiene 4 grados.
- b- Disnea de Reposo. Ortopnea, Trepopnea, Platipnea.
- c- Disnea Paroxística. Cardíaca, Bronquial (Asma).

Disnea de Presentación Aguda

Insuf. Cardíaca izquierda
Crisis Asmática
Tromboembolismo Pulmonar
Neumonías
Neumotórax.
Ansiedad-Pánico
Politraumatismo

Disnea de Presentación Crónica

EPOC
Insuf. Cardíaca crónica
Anemias
Obesidad.
Derrames Pleurales
Ascitis. Embarazo.

ESP. ROMETRIA

Px de TORAX

GASOMETRIA

HEMOGRAMA

EXGOMETRIA

ECO CARDIOGRAMA

Centros Respiratorios

2 Bulbos = Inspiratorio y Expiratorio

2 Protuberancias = Apnéustico y Neumotáxico

DOLOR TORÁCICO

(5)

Desde el punto de vista fisiopatológico se clasifica en :

1. Dolor Visceral: se caracteriza por ser mal localizado, difuso, tiene carácter retroesternal, de tipo úrente y se acompaña de tos frecuente, irritativa, seca, persistente, puede irradiarse a los lados de la cara anterior del tórax y paraesternal alta. Tienen su origen en afecciones traqueobronquiales. El parénquima pulmonar no tiene receptores nociceptivos, por lo tanto no producen dolor. Si la patología respiratoria compromete la pleura parietal, mediastinal o diafragmática si se expresa por dolor. El dolor torácico de tipo visceral obedece frecuentemente a causas extrarrespiratorias y que son muy importantes como ser la Angina de pecho, el infarto de miocardio, el Aneurisma Disecante de Aorta, las Pericarditis y la patología Esofágica.

2. Dolor Referido: de causa extratorácica, especialmente abdominales que asientan en órganos intradiaphragmáticos y supramesocólicos, son referidos a la región retroesternal y a ambos hipocondrios, también a dorso. Importante tenerlos en cuenta por su frecuencia.

3. Dolor Somático: es por afectación de las estructuras osteoartromusculares de la caja torácica y de la pleura parietal. Se caracterizan por ser dolores bien localizados, precisables "con la punta del dedo" y aumentar con la presión local su intensidad. El dolor pleural da la típica "Puntada de costado" localizado en región axilar, tipo punzada como su nombre lo indica, generalmente intenso, iniciado o exacerbado por los movimientos respiratorios, interfiere la respiración y obliga a adoptar el decúbito lateral, contralateral al afectado. Igualmente características del dolor producen el compromiso pleural mediastinal y diafragmático. En este último hay paresia de hemidiafragma afecto y el dolor es referido al homolateral además hay Hipo peritina.

Las patologías que dan dolor torácico somático por compromiso pleural parietal son frecuentes: Neumonías, Embolia pulmonar, Neumotórax, Neoplásia pulmonar.

Otros Síndromes Parietales dolorosos:

- a- Síndrome de Tietze: tumefacción unilateral, sin rubor ni calor, pero muy doloroso espontáneamente y a la palpación, asienta generalmente en la primera, segunda o tercera articulación condroesternal, izquierda o derecha.
- b- Síndrome de Pancoast-Tobias o Apicocostovertebral: por invasión del plexo braquial por carcinoma pulmonar a nivel del vértice. Dolor de hombro, dorso y cara interna del brazo homolateral.
- c- Síndrome del Desfiladero Costoclavicular: se da por compresión del paquete vasculonervioso a su paso por el orificio superior del tórax constituido por los músculos escalenos, el pto costo clavicular y la inserción del pectoral menor. Las causas óseas son: costilla cervical, Megaostrosis transversa vertebrales o costales. Las musculares son: hipertrofia de escalenos, o músculo subclavio o aponeurosis interescalénicas. La compresión da síntomas vasculares o nerviosos. Hay dolor continuo o intermitente, espontáneo o desencadenados por ciertas posturas o movimientos. También hay parestesias.
- d- Síndrome de Cyriax-Davis-Colley: dolor en extremo distal de costillas flotantes. La compresión digital de las mismas reproduce el dolor "signo de la tecla".
- e- Síndrome de Compresión radicular: lesiones vertebrales de diverso origen dan dolor con hipo o hiperestésias en banda o franjas.